

论文本身的内容

论文信息

- 英文标题: Older adults' digital technology experiences: a qualitative study
- 中文标题: 《老年人的数字技术使用体验: 一项定性研究》
- 作者: Lina Emmesjo, Jenny Hallgren, Catharina Gillsjo
- 期刊: BMC Digital Health
- 年份: 2025
- DOI: [10.1186/s44247-025-00163-7](https://doi.org/10.1186/s44247-025-00163-7)
- 论文页面: [BMC Digital Health 文章页](#)
- 本地 PDF: [older-digital-technology-experiences.pdf](#)

一句话概括

这篇论文讲的是:

老年人在日常生活和健康/社会照护场景里使用数字技术时, 同时感受到便利、丰富、依赖、矛盾和支持需求, 因此老年人的数字体验不能被看成单一的“接受”或“拒绝”。

研究背景

论文背景是, 现代社会越来越依赖移动应用和 web applications, 老年人也越来越多地接触数字技术。在健康和社会照护领域, 数字技术被期待帮助老年人:

- 维持独立生活
- 提升安全感
- 改善整体福祉

但是, 已有研究也发现:

- 当前很多数字技术对老年人来说并不容易使用
- 老年人虽然可能对某些移动解决方案持积极态度
- 但真实使用体验往往更复杂

因此, 作者认为还需要进一步探索:

老年人自己到底怎样体验这些数字技术。

问题 (Challenge)

这篇论文要解决的问题是:

老年人在真实生活里如何体验数字技术? 这些体验有哪些收益、困难、依赖和分化偏好?

这个问题有挑战性, 是因为老年人的数字使用很容易被外部观察简化成几种粗糙说法:

- 会用 / 不会用
- 接受 / 不接受
- 线上方便 / 线下落后

但现实并不是这样。

同一个老人可能：

- 在某些任务上觉得数字技术很好
- 在另一些任务上又觉得麻烦或不安
- 可能愿意线上获取信息
- 但不愿意线上和医疗照护系统深度互动

所以难点在于：

- 老年人的体验本身是分化的、矛盾的、依赖具体场景的
- 不能用一个统一态度去概括

作者的发现（Finding）

我认为这篇论文最核心的 finding 是：

老年人的数字技术体验具有明显的双重性和异质性。数字技术既可能丰富日常生活，也可能增加依赖；既可能被欢迎，也可能引发矛盾情绪；而且不同老人、不同场景下的偏好差异很大。

这个 finding 为什么重要？

因为它把问题从“老年人是否接受数字技术”翻成了：

数字技术在什么条件下能支持老年人的自主生活，在什么条件下又会让他们更依赖别人。

这是一种很关键的视角变化。

它不再把重点放在“老年人有没有跟上技术”，而是放在“技术有没有真正适配老年人的生活方式和支持需求”。

方法

研究设计

- qualitative design
- 也就是定性研究设计

数据收集

- 使用 semi-structured interviews
- 也就是半结构式访谈

样本

- 17 位老年人
- 年龄范围 72 到 101 岁
- 来自 12 个不同 municipality
- 这些老年人都接受 municipality health care

访谈方式

- 在老年人家中进行访谈
- 访谈过程被录音

- 随后转写成文本

数据分析

- qualitative conventional content analysis
- 研究过程遵循 COREQ checklist

也就是说，这篇论文不是用问卷打分，而是通过访谈老年人自己的叙述，归纳他们如何理解和感受数字技术。

结论

论文分析出了两大主要类别。

第一大类

Enrichment, dependence and mixed feelings of using digital technology in daily life

可以理解为：

数字技术在日常生活中既带来丰富感，也带来依赖感和复杂情绪。

这一类下面有三个子主题。

1. Divided usage and feelings about digital technology

老年人对数字技术的使用和感受是分裂的、混合的，不是简单喜欢或讨厌。

例如可以这样理解：

- 某些功能很方便
- 但某些功能又让人不安
- 某些人觉得数字技术值得学
- 某些人则觉得太复杂、太依赖别人

2. Enriching daily life with digital technology

数字技术确实能在一些方面丰富老年人的日常生活。

例如：

- 获取信息更方便
- 和外界保持联系更容易
- 某些日常事务处理更便捷

这说明，论文不是单纯强调障碍，它也承认数字技术对老年人生活的积极价值。

3. Need for support when using digital technology

这是这篇论文特别重要的点。

很多老年人并不是完全不能使用数字技术，而是：

- 需要支持
- 需要解释
- 需要学习

- 需要他人在关键节点上帮忙

这表明支持和教育不是可有可无的附加项，而是数字使用能否持续的重要条件。

第二大类

Divided preferences and use of digital technology in contact with health and social care

可以理解为：

在和健康及社会照护系统打交道时，老年人对数字技术的偏好和使用也是分化的。

这一类下面有两个子主题。

1. Divided experiences regarding digital communication with health and social care

老年人对数字化沟通并不是统一积极的。

他们可能：

- 在某些情境下愿意接受数字沟通
- 在另一些情境下更想要线下或人工沟通

也就是说，数字化医疗/照护接触不只是技术问题，还涉及：

- 信任
- 理解
- 重要性
- 沟通方式是否让人安心

2. A longing for information about healthcare through digital technology

这部分表明，老年人并不一定排斥通过数字技术获取医疗相关信息。

相反，他们可能希望数字技术能更好地提供有用、可理解的信息。

这说明：

- 老年人不是“一概拒绝数字健康”
- 他们更像是在区分：什么样的信息或互动适合数字化，什么样的不适合

作者的总体结论

论文最后强调了几件事。

结论 1

老年人不能被看成一个在数字使用上同质化的群体。

结论 2

数字技术既可能支持独立生活，也可能在缺乏支持时增加对他人的依赖。

结论 3

支持和教育是必需的，不是可有可无的。

结论 4

健康照护专业人员和政策制定者在决定是否采用数字技术时，应该先理解老年人的个体偏好和具体情境。

结论 5

老年人应当参与到为他们设计的数字技术中，否则技术可能进一步放大依赖和排斥。

关键术语与概念

semi-structured interviews + 半结构式访谈

研究者提前准备核心问题，但允许受访者顺着自己的经验展开回答。

例子：

研究者会问“你平时怎么用数字技术”，但不会强行限制回答范围。

qualitative conventional content analysis + 常规定性内容分析

研究者从受访者叙述中归纳主题和类别，而不是先套用固定量表。

例子：

如果很多老人都提到“既方便又麻烦”“会用一点但要人帮”，研究者就会把这些经验整理成主题。

mixed feelings + 混合情绪 / 矛盾感受

指一个人对数字技术并不是纯粹正面或负面，而是同时存在认可和抗拒。

例子：

一个老人可能觉得视频问诊省时间，但又觉得没有面对面安心。

dependence + 依赖

指个体在使用数字技术时越来越需要别人帮助，缺乏独立完成能力。

例子：

每次需要登录、验证或提交表单时，都必须让家人代操作。

heterogeneity + 异质性

指老年人群体内部差异很大，不能当成统一人设。

例子：

同样是 80 多岁，有的人乐于学新技术，有的人只愿意使用最熟悉的几个功能。

最后一句总结

这篇论文的核心不是“老年人喜欢还是不喜欢数字技术”，而是：

老年人的数字体验同时包含便利、丰富、依赖、支持需求和场景化偏好；只有承认这种复杂性，才能真正理解他们为什么在某些任务中继续尝试，在另一些任务中转向依赖或放弃。